EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 80034
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-04 13:10:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: AURORA DEL C ACUNA CARRASCO			RUN	: 3.174.424-5
F.Nac	: 21-08-1928	Edad	: 95 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: GAONA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 000		
Fecha Ingreso	: 2024-03-01	Fecha Egreso	: 2024-03-04 13:10:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D64.9-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

HDA
HTA
Limitacion severa ABVD
ENf de Alzheimer

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, derivada desde APS el 01/03 por cuadro de deposiciones de aspecto melenicopalidez mucocutanea, HB control 3,4. Se realiza tacto rectal a su ingreso, sin evidencia de melena en ampolla rectal. Se decide hospitalizar para estudio.
Durante estancia estable, se procede a realizacion de Tr de 2 UI de Gr. Debido a costo beneficio de estudio invasivo, se desestima estudio endoscopico, para priorizar cuidados de fin de vida
Examenes de control con Hb 8,3 -> 7,2, con disminucion de deposiciones de aspecto melenico, sin beneficio de continuar hospitazada por conflito en esfera GI.
Desde el punto de vista respiratorio con abundante movilizacion de secreciones en via aerea superior, con requierimiento de KNT respiratoria y aspiracion de secreciones.
SIn uso de O2 suplementario, desde ingreso, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos.

Ex fisico -> Vigil, desorietnada en tiempo y esapcio, mucosas levemente palidas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
ABdomen BD, sensible de caracter difuso; RHA (+)
Extremidades anquilosadas

Actualmente cursando su dia N° 3 hospitalizada, en condiciones de continuar rehabilitacion kinesiologica via HODOM

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Gi: Sin beneficio de continuar estudio invasivo, se desestima
4) KNT: Se continuara con rehabilitacion motora y respiratoria

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada
2. Regimen papilla a tolerancia
3. Quetiapina 100 mg, medio comp c/12 hrs VO
4. Omeprazol 40 mg al dia VO por 7 dias
5. Metoclopramida 10 mg c/12 hrs VO por 7 dias
6. Lactulosa 10 cc c/12 hrs VO por 7 dias
7. KNT respiratoria y motora una vez al dia
8. Continuar con tratamiento cronico

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO